

Bogen A

Patient:innen-Vorab-Anamnese und Stratifizierung

Version V6.1 - professionelle Arbeits- und Diskussionsfassung | Stand: 11.05.2026

Ziel: strukturierte patientenberichtete Voranamnese zur frühen Einordnung von Gelenkbeschwerden, zur Vorbereitung von RheumaCheck-Testung, digitaler Terminsteuerung und klinischer Stratifizierung.

Dokumenttyp	Patient:innenfragebogen; Papier-/Word-Entwurf mit digitaler Strukturvorgabe
Zielgruppe	Personen mit unklaren Gelenkbeschwerden, Verdacht auf entzündlich-rheumatische Erkrankung oder geplanter RheumaCheck-Nutzung
Einordnung V6	Bogen A ist der patientengerichtete Eingangsbogen. Bogen B richtet sich an Rheumanetzwerk/Ärzt:innen zur Standardmethode; Bogen C bewertet Patient:innen-Usability nach Nutzung; Bogen D fragt ärztliche Implementierbarkeit und erwarteten Nutzen ab.
Status	V6.1-Arbeitsfassung; vor externer Nutzung zunächst mit Robert Lange / salvevita grob und danach klinisch mit Michael Zänker / IKB fein abzustimmen.

1. Warum Bogen A benötigt wird

Bogen A operationalisiert die in der RheumaCheck-Projektlogik angelegte Verbindung von Testdaten, klinischem Fragebogen / Anamnese, Patient:innen-Stratifizierung und digital unterstützter Zuweisung. Der Bogen soll keine Diagnose stellen. Er soll typische Hinweise auf entzündlich-rheumatische Beschwerden strukturiert erfassen, damit die späteren Testdaten nicht isoliert, sondern zusammen mit relevanten Symptomen, Dauer, Funktion und bisheriger Abklärung bewertet werden können.

- Patient:innen geben vor Test bzw. digitaler Einordnung zentrale Beschwerden und Kontextdaten an.
- Die Angaben können später mit CRP/RF/Anti-CCP-Testdaten und App-/CUBE-Ergebnissen kombiniert werden.
- Der Bogen schafft eine auswertbare Grundlage für Stratifizierung, Terminsteuerung und spätere Begleitforschung.
- Er bleibt bewusst laienverständlich und ist für Papier, Online-Formular oder App-Integration geeignet.

2. Quellen- und Projektbezug

Quelle/Projektspur	Bedeutung für Bogen A
Gesamtvorhaben / telediagnostische Plattform	Testdaten sollen mit klinischem Fragebogen / Anamnese und digitaler Auswertung zusammengeführt werden. Daraus folgt ein patientengerichteter Eingangsbogen.
AP4 / digitale Einbindung	Der Fragebogen muss perspektivisch digital und interaktiv abbildbar sein, nicht nur als statisches Papierdokument.
AP7 / Machbarkeitsstudie	Patientenbefragung und Stratifizierung sind Teil der späteren Machbarkeits- und Validierungslogik.
IKB-Teilvorhaben	Patient:innen mit Gelenkschmerzen bzw. gesicherter RA sollen klinisch eingeordnet werden; Patientendaten sollen für Stratifizierung und Software-Einlernen nutzbar sein.
Jour fixe 09.04.2026	Fragebögen und Begleitforschung bleiben IMDB-Aufgabe; erst GrobAbstimmung mit Robert Lange, danach Feinabstimmung mit Michael Zänker.
Jour fixe 07.05.2026	IMDB hat erste Vorarbeiten begonnen; Fragebogen- und Begleitforschungsthemen müssen weiter geschärft werden.

3. Einsatzlogik und Zielgruppe

Element	Empfehlung
Primäre Zielgruppe	Patient:innen mit unklaren Gelenkbeschwerden, Verdacht auf entzündlich-rheumatische Erkrankung oder geplanter RheumaCheck-Testung.
Einsatzzeitpunkt	Vor Testdurchführung, vor digitaler Terminsteuerung oder vor Einschluss in eine Machbarkeits-/Pilotstudie.
Bearbeitungsdauer	Kurzversion 4-6 Minuten; Vollversion 7-10 Minuten.
Format	Zunächst Word/Papier und Online-Formular; später App-/Plattform-Integration mit Sprunglogik.
Nicht-Ziel	Der Bogen ist kein Diagnoseinstrument und ersetzt keine ärztliche Abklärung.

4. Einleitungstext für Patient:innen

Vorab-Fragebogen RheumaCheck

Mit diesem kurzen Fragebogen möchten wir Ihre Beschwerden und Ihre bisherige Abklärung besser einordnen. Ihre Angaben helfen dabei, den weiteren Ablauf im RheumaCheck-Projekt vorzubereiten und typische Hinweise auf entzündlich-rheumatische Beschwerden strukturiert zu erfassen.

Bitte beantworten Sie die Fragen so gut wie möglich. Wenn Sie etwas nicht genau wissen, wählen Sie bitte „weiß ich nicht“ oder schätzen Sie möglichst realistisch. Der Fragebogen ersetzt keine ärztliche Untersuchung. Bei starken oder plötzlich zunehmenden Beschwerden wenden Sie sich bitte an eine Ärztin oder einen Arzt.

5. Fragebogen - Vollversion V6.1

A. Basisdaten und aktueller Anlass

1. Wie alt sind Sie?

Zweck: Altersbezogene Einordnung der Beschwerden und Nutzbarkeit der späteren Stratifizierung.

Antwortformat: Zahlenfeld oder Altersgruppe: unter 18; 18-34; 35-44; 45-54; 55-64; 65-74; 75+; keine Angabe.

Auswertung / digitale Logik: Für digitale Nutzung bevorzugt Altersgruppe statt Geburtsdatum, sofern keine Studien-ID/Einwilligung vorliegt.

2. Welches Geschlecht wurde Ihnen bei Geburt zugeordnet bzw. welches Geschlecht möchten Sie angeben? (optional)

Zweck: Medizinische und epidemiologische Einordnung; optional sensibel formulieren.

Antwortformat: Einfachauswahl: weiblich; männlich; divers; keine Angabe.

Auswertung / digitale Logik: Optional, wenn nicht für Auswertung zwingend erforderlich.

3. Warum füllen Sie den Fragebogen aus?

Zweck: Zuordnung des Nutzungsszenarios.

Antwortformat: Einfachauswahl: neue Gelenkbeschwerden; bestehende Beschwerden ohne Diagnose; Verdacht auf Rheuma; bekannte rheumatische Erkrankung; Vorbereitung auf RheumaCheck-Test; Empfehlung durch Ärztin/Arzt; Sonstiges.

Auswertung / digitale Logik: Digitale Weiche für Erstverdacht vs. bekannte Diagnose.

4. Seit wann bestehen Ihre aktuellen Gelenkbeschwerden?

Zweck: Dauer der Symptome als zentraler Stratifizierungs- und Referral-Hinweis.

Antwortformat: Einfachauswahl: weniger als 2 Wochen; 2-6 Wochen; mehr als 6 Wochen bis 3 Monate; länger als 3 Monate; Beschwerden kommen und gehen; weiß ich nicht.

Auswertung / digitale Logik: Dauer >6 Wochen und besonders >3 Monate als relevantes Signal für weitere Abklärung.

B. Gelenkbeschwerden und entzündliche Hinweise

5. Haben Sie aktuell Schmerzen in einem oder mehreren Gelenken?

Zweck: Basisfrage für Gelenkbeteiligung.

Antwortformat: Einfachauswahl: ja; nein; unsicher.

Auswertung / digitale Logik: Wenn nein: Kurzpfad möglich; wenn ja: Detailfragen anzeigen.

6. Haben Sie geschwollene Gelenke bemerkt?

Zweck: Schwellung ist ein zentraler Hinweis auf Synovitis/entzündliche Aktivität.

Antwortformat: Einfachauswahl: ja, deutlich; ja, leicht; nein; unsicher.

Auswertung / digitale Logik: Bei ja/unsicher: betroffene Gelenke und Dauer vertiefen.

7. Sind Gelenke morgens nach dem Aufstehen steif?

Zweck: Morgensteifigkeit ist ein typischer entzündlicher Hinweis.

Antwortformat: Einfachauswahl: ja; nein; unsicher.

Auswertung / digitale Logik: Wenn ja: Frage 8 anzeigen.

8. Wie lange dauert die Morgensteifigkeit ungefähr?

Zweck: Dauer der Morgensteifigkeit als Schwere-/Entzündungshinweis.

Antwortformat: Einfachauswahl: unter 10 Minuten; 10-30 Minuten; 30-60 Minuten; länger als 60 Minuten; kann ich nicht einschätzen.

Auswertung / digitale Logik: >=30 Minuten als relevanter Hinweis; nicht allein diagnostisch verwenden.

9. Welche Gelenkregionen sind betroffen?

Zweck: Erfassung kleiner und großer Gelenke.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Fingergrund-/Fingermittelgelenke; Handgelenke; Zehen; Vorfuß-/Fußgelenke; Knie; Ellenbogen; Schultern; Hüfte; Kiefer; Wirbelsäule/Rücken; andere; unsicher.

Auswertung / digitale Logik: Kleine Hand-/Fußgelenke gesondert markieren.

10. Wie viele Gelenke sind ungefähr betroffen?

Zweck: Mehrgelenkbeteiligung und Ausmaß der Beschwerden.

Antwortformat: Einfachauswahl: 1 Gelenk; 2-3 Gelenke; 4-10 Gelenke; mehr als 10 Gelenke; wechselnd; weiß ich nicht.

Auswertung / digitale Logik: Mehr als ein Gelenk als wichtiger Referral-/Stratifizierungsmarker.

11. Treten die Beschwerden auf beiden Körperseiten ähnlich auf?

Zweck: Symmetrie als klassischer Hinweis, aber nicht zwingend.

Antwortformat: Einfachauswahl: ja, eher symmetrisch; eher einseitig; wechselnd; unsicher.

Auswertung / digitale Logik: Symmetrie als unterstützendes Signal, nicht als Ausschlusskriterium.

12. Sind betroffene Gelenke warm, gerötet oder besonders druckempfindlich?

Zweck: Erfassung weiterer Entzündungszeichen.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: warm; gerötet; druckempfindlich; keine dieser Beobachtungen; unsicher.

Auswertung / digitale Logik: Bei starker Rötung/Fieber: Hinweis auf ärztliche Abklärung, nicht nur RheumaCheck.

C. Schmerz, Funktion und globale Belastung

13. Wie stark sind Ihre Gelenkschmerzen aktuell?

Zweck: Patientenberichtete Schmerzstärke.

Antwortformat: 0-10-Skala: 0 = keine Schmerzen, 10 = stärkste vorstellbare Schmerzen.

Auswertung / digitale Logik: Kann später mit Testdaten und globalem Eindruck kombiniert werden.

14. Wie stark beeinträchtigen die Beschwerden Ihren Alltag insgesamt?

Zweck: Patient:innenrelevanter Funktions- und Belastungsindikator.

Antwortformat: 0-10-Skala: 0 = gar nicht, 10 = sehr stark.

Auswertung / digitale Logik: Nützlich für Priorisierung und Begleitforschung.

15. Welche Tätigkeiten fallen Ihnen wegen der Beschwerden schwer?

Zweck: Kurze funktionsorientierte Erfassung, angelehnt an patientenberichtete Funktionslogik.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Faust schließen; Flasche/Glas öffnen; Knöpfe/Reißverschluss; Schreiben/Tippen; Treppensteigen; längeres Gehen; Aufstehen aus Stuhl/Bett; Körperpflege/Anziehen; keine; Sonstiges.

Auswertung / digitale Logik: Digitale Kurzform für Funktion; keine vollständige HAQ-Ersetzung.

16. Wie würden Sie Ihren allgemeinen Gesundheitszustand heute einschätzen? (optional)

Zweck: Patient Global als einfacher, digital nutzbarer PRO-Anker.

Antwortformat: 0-10-Skala: 0 = sehr gut, 10 = sehr schlecht.

Auswertung / digitale Logik: Kann später mit RAPID3-/PRO-Logik verglichen werden.

D. Bisherige Abklärung und bekannte Befunde

17. Waren Sie wegen dieser Beschwerden bereits ärztlich vorstellig?

Zweck: Einordnung des bisherigen Abklärungsstands.

Antwortformat: Einfachauswahl: nein; ja, Hausarztpraxis; ja, Orthopädie; ja, Rheumatologie; ja, Klinik/Notaufnahme; ja, andere Fachrichtung; mehrere.

Auswertung / digitale Logik: Wenn ja: Arzt-/Diagnostikdetails anzeigen; wenn nein: Standardmethode-Fragen ggf. in Bogen B/C nicht relevant.

18. Wurden bereits Blutwerte im Zusammenhang mit den Beschwerden bestimmt?

Zweck: Erfassung relevanter Labordiagnostik.

Antwortformat: Einfachauswahl: ja; nein; weiß ich nicht.

Auswertung / digitale Logik: Wenn ja: Frage 19 anzeigen.

19. Welche Werte wurden nach Ihrem Wissen bereits bestimmt? (optional)

Zweck: Erfassung von RF/Anti-CCP/CRP/BSG und Vorbefunden.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Rheumafaktor/RF; Anti-CCP/ACPA; CRP; BSG/Blutsenkung; ANA; HLA-B27; weiß ich nicht; andere.

Auswertung / digitale Logik: Kann später mit RheumaCheck-Testdaten abgeglichen werden.

20. Wurde bei Ihnen bereits eine rheumatische Erkrankung diagnostiziert oder vermutet?

Zweck: Unterscheidung Erstverdacht vs. bekannte Erkrankung.

Antwortformat: Einfachauswahl: nein; Verdacht geäußert; rheumatoide Arthritis; andere entzündlich-rheumatische Erkrankung; Arthrose; Gicht; weiß ich nicht.

Auswertung / digitale Logik: Digitale Weiche: Erstscreening vs. Verlauf/Monitoring.

21. Nehmen Sie aktuell Medikamente gegen die Beschwerden oder eine rheumatische Erkrankung ein? (optional)

Zweck: Kontext für Interpretation von Beschwerden und Entzündungswerten.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: keine; Schmerzmittel/NSAR; Kortison; DMARD/Basistherapie; Biologikum/JAK-Inhibitor; weiß ich nicht; Sonstiges.

Auswertung / digitale Logik: Optional, da medizinisch sensibel und im Pilot ggf. zu lang.

E. Dringlichkeit, Erwartungen und RheumaCheck-Kontext

22. Haben Sie bereits einen Termin bei einer Rheumatologin / einem Rheumatologen?

Zweck: Erfassung aktueller Versorgungssituation.

Antwortformat: Einfachauswahl: nein; ja, Termin innerhalb von 4 Wochen; ja, Termin in 1-3 Monaten; ja, später als 3 Monate; ich war bereits dort; unklar.

Auswertung / digitale Logik: Hilft, Verzögerungen und Nutzen einer Vorselektion zu erfassen.

23. Was erhoffen Sie sich von RheumaCheck?

Zweck: Erwartungen der Patient:innen und Akzeptanz.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: schnellere Einordnung; mehr Sicherheit; schnellere Überweisung; bessere Vorbereitung auf Arzttermin; Verlaufskontrolle; verständliche Ergebnisanzeige; weiß ich nicht; Sonstiges.

Auswertung / digitale Logik: Nützlich für Patient:innenkommunikation und Begleitforschung.

24. Wären Sie bereit, einen kleinen Blutstropfen aus der Fingerbeere für einen Test abzugeben?

Zweck: Akzeptanz der Kapillarblut-/POC-Komponente.

Antwortformat: Einfachauswahl: ja; eher ja; unsicher; eher nein; nein.

Auswertung / digitale Logik: Für spätere Testworkflow-Planung relevant.

25. Gibt es etwas Wichtiges, das wir zu Ihren Beschwerden wissen sollten? (optional)

Zweck: Offene Ergänzung für nicht antizipierte Aspekte.

Antwortformat: Kurzes Freitextfeld, optional.

Auswertung / digitale Logik: Qualitative Ergänzung; sparsam verwenden.

6. Kurzversion für frühe Pilotierung

Für eine erste Pilotierung oder App-Mock-up-Testung sollte zunächst eine Kurzversion mit 12 Kernfragen verwendet werden. Diese reduziert Belastung und liefert dennoch die wichtigsten Stratifizierungsinformationen.

Nr.	Kurzfrage	Antwortformat
K1	Alter / Altersgruppe	Zahlenfeld oder Altersgruppe
K2	Grund der Befragung	Einfachauswahl
K3	Dauer der Gelenksbeschwerden	Einfachauswahl
K4	Gelenkschmerzen aktuell	Ja/Nein/Unsicher
K5	Gelenkschwellung	Ja/Nein/Unsicher
K6	Morgensteifigkeit und Dauer	Sprunglogik
K7	Betroffene Gelenkregionen	Mehrfachauswahl
K8	Anzahl betroffener Gelenke	Einfachauswahl
K9	Schmerz 0-10	Skala
K10	Alltagsbeeinträchtigung 0-10	Skala
K11	Bisherige ärztliche Abklärung	Einfach-/Mehrfachauswahl
K12	Bekannte RF/Anti-CCP/CRP/BSG-Werte	Mehrfachauswahl / weiß ich nicht

7. Digitale Struktur und Sprunglogik

- Wenn keine aktuellen Gelenkschmerzen und keine Schwellung: Kurzpfad mit Hinweis, dass RheumaCheck für aktuelle Gelenksbeschwerden vorgesehen ist.
- Wenn Morgensteifigkeit ja: Dauer abfragen; wenn nein: Dauerfrage ausblenden.
- Wenn kleine Hand-/Fußgelenke betroffen oder mehr als ein Gelenk betroffen: intern als erhöhter Abklärungsbedarf markieren.
- Wenn Beschwerden länger als 3 Monate bestehen und noch keine ärztliche Abklärung erfolgte: Hinweis auf zeitnahe medizinische Abklärung anzeigen.
- Wenn bereits bekannte RA oder laufende DMARD-/Biologika-Therapie: als Verlauf-/Monitoring-Szenario markieren, nicht als Erstscreening.
- Wenn Labordaten unbekannt: kein Abbruch; RheumaCheck soll gerade niederschwellige Orientierung ermöglichen.
- Freitextfelder sparsam halten, damit die spätere Auswertung standardisiert möglich bleibt.

8. Interne Stratifizierungslogik - Vorschlag

Die folgende Logik ist kein Diagnose-Score. Sie dient nur als interne Diskussionsgrundlage für Robert Lange / salvevita und Michael Zänker / IKB.

Marker	Begründung / Nutzung
Symptome >6 Wochen	Relevanter Dauerhinweis; unterstützt Abgrenzung kurzfristiger Beschwerden.
Verzögerung >3 Monate	Sollte im Versorgungspfad besonders markiert werden.
Schwellung angegeben	Hinweis auf mögliche Synovitis/Entzündung; klinisch zu plausibilisieren.
Kleine Hand-/Fußgelenke betroffen	Wichtiger Referral- und Prognosehinweis bei RA-Verdacht.
Mehr als ein Gelenk betroffen	Wichtiger Hinweis für rheumatologische Abklärung.
Morgensteifigkeit ≥30 Minuten	Typisches entzündliches Symptom; nicht allein diagnostisch.
Schmerz / Alltagsbeeinträchtigung hoch	Patient:innenrelevanter Belastungs- und Priorisierungsmarker.
RF/Anti-CCP/CRP/BSG bekannt auffällig	Kann mit Testdaten und klinischem Kontext kombiniert werden.

9. Abstimmungspunkte

Mit Robert Lange / salvevita	Mit Michael Zänker / IKB	Mit Prof. Frank Bier / IMDB
Welche Fragen sollen direkt in die App / Plattform integriert werden?	Sind die Symptomfragen klinisch passend und ausreichend?	Welche Datenfelder sind für Quantifizierung, Validierung und Auswertung notwendig?
Welche Sprunglogik ist technisch sinnvoll?	Welche Kriterien sollen eine priorisierte Abklärung auslösen?	Wie sollen Testdaten und Fragebogenwerte gemeinsam analysiert werden?
Welche Felder sind Pflichtfelder, welche optional?	Welche Formulierungen sind patientenverständlich und klinisch nicht irreführend?	Welche Mindestdaten werden für Bericht, Studie und Förderlogik gebraucht?

10. Qualitäts-, Datenschutz- und Anwendungshinweise

- Bogen A sollte keine Diagnoseversprechen enthalten und keine ärztliche Abklärung ersetzen.
- Patientenidentifizierende Angaben sollten nur erhoben werden, wenn Studien-/Datenschutzlogik und Einwilligung geklärt sind.
- Für frühe Tests reicht eine pseudonymisierte Studien-ID plus Altersgruppe; Kontaktangaben sollten getrennt verwaltet werden.
- Vor externer Nutzung sollte eine kurze verständliche Datenschutzhinweis- und Einwilligungslogik ergänzt werden.
- Bogen A sollte später technisch mit Bogen C verknüpft werden, damit Nutzungserfahrung und Ausgangssymptomatik gemeinsam ausgewertet werden können.

11. Externe fachliche Orientierung

Für die fachliche Rahmung wurden aktuelle RA-Referral- und Klassifikationsorientierungen berücksichtigt. NICE empfiehlt bei Verdacht auf persistierende Synovitis die Überweisung zur fachärztlichen Einschätzung und besonders dringliche Abklärung, wenn kleine Hand-/Fußgelenke betroffen sind, mehr als ein Gelenk betroffen ist oder eine Verzögerung von drei Monaten oder länger vorliegt. Die ACR/EULAR-RA-Klassifikation berücksichtigt Gelenkbeteiligung, Serologie, Akutphaseparameter und Symptombdauer. Telemedizinisch nutzbare RA-Maße und patientenberichtete Outcomes unterstützen die Idee, symptom- und funktionsbezogene Patient:innenangaben strukturiert zu erfassen.

- NICE NG100: Rheumatoid arthritis in adults - referral, diagnosis and management.
- ACR/EULAR 2010 classification criteria: Gelenkbeteiligung, Serologie, Akutphaseparameter, Symptombdauer.
- ACR/Telehealth-orientierte PRO-Logik: patientenberichtete Schmerz-, Funktions- und globale Einschätzungen können digital nutzbar sein.

12. Fazit

Bogen A V6.1 ist der patientengerichtete Eingangsbogen des V6-Fragebogenpakets. Er ersetzt keine klinische Diagnose, ist aber geeignet, relevante Symptome, Dauer, Funktionsbeeinträchtigung, bisherige Abklärung und Akzeptanz der RheumaCheck-Nutzung strukturiert zu erfassen. Damit bildet er die Grundlage für digitale Stratifizierung, spätere Testdatenintegration und patientenbezogene Begleitforschung.